115年第二次專技高等考試營養師、護理師、社會工作師考試、115年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試

代　　號：4112
類科名稱：諮商心理師
科目名稱：心理健康與變態心理學
考試時間：2小時　　座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

一、申論題

※本題為申論題，請使用鍵盤及滑鼠輸入作答內容，由左至右橫式作答。

1.長期敵意的人有較高風險罹患冠狀動脈心臟病。敵意與冠心病的連結主要由壓力的四個生理反應歷程所解釋，這四個歷程也是構成適應負荷（allostatic load）的四大面向。請列出四大面向，分別說明其意涵，並舉例為什麼敵意會在這四大面向上增加適應負荷。（20分）

2.有研究支持廣泛性焦慮症（generalized anxiety disorder, GAD）會出現「迴避情緒」。請解釋「迴避情緒」的形成歷程，（15分）以及個別諮商GAD的處遇原則。（15分）

二、測驗題

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.心理不健康者對家庭、社會都會帶來困擾，下列何者是2024年精神衛生法對嚴重病人的定義？

A.呈現出與現實脫節之精神狀態，致不能處理自己事務，經專科醫師診斷認定者

B.反社會人格違常者

C.有緊急暴力、自殺或自傷之危險者

D.使用非法物質致使思考、情緒、知覺、認知、行為及其他精神狀態表現異常，使其生命或身體有立即之危險或有危險之虞者

2.行政院衛生福利部對健康所下的定義，可就生物層面、心理層面、社會層面來說明，下列何者錯誤？

A.健康的心理與健康的身體交互影響，有了健康的身體有助於個人在情感、意識認知及行為上的正常運作

B.心理健康的人在認知系統與環境適應系統上能保持正常而有效率、能兼顧自我的發展與人際關係之和諧，且完全不使用心理防衛機轉

C.心理健康的人在社會環境中的有效適應，是指個人角色之扮演符合社會的要求，能與環境保持良好的接觸，亦能為社會貢獻其心力

D.心理健康與心理不健康不是絕對的兩面，「天下無絕對健康之人，亦無絕對不健康之人」

3.世界各國皆以促進國民的心理健康為要務，下列何者不是探討心理衛生重要性的面向？

A.心理障礙症人數日趨減少

B.心理障礙症帶給家庭嚴重的困擾

C.心理障礙症威脅到社會的安寧

D.心理健康者才能發揮其個人潛能

4.心理健康發展深受幼兒和照顧者間的互動品質影響，下列敘述何者錯誤？

A.正向教養不等於溺愛

B.藉由溫和堅定的方式來達到控制孩子以建立行為規範之目的，是正向教養的核心理念

C.照顧者不只要學習如何正向引導，也要了解孩子的生理發展過程

D.具體描述孩子那些行為做得好將有助於建立孩子的信心

5.關於Meyer Friedman和Ray Rosenman的A型人格（Type A personality）理論內容，下列敘述何者錯誤？

A.是用來說明穩定行為模式對心血管疾病的影響

B.核心特徵包含成就競爭取向

C.是A群人格障礙症的危險因子

D.是由心臟學家，而非心理學家，發現而提出的

6.一系列實驗測試在群眾面前進行演講時，如果有好友在場（能提供社會支持的人），演講者的心血管反應性（cardiovascular reactivity）會改變。關於這系列研究，下列何者正確？

A.社會支持降低心血管反應性，若寵物在場則不在此範圍

B.有些研究發現，友人的出現也可能反而增加心血管反應性

C.社會支持可以抵銷一般適應症候群（general adaptation syndrome）的代價

D.社會支持對健康的影響，包括中介假說（mediation hypothesis）

7.針對疼痛的人際取向心理治療的主要目標是什麼？

A.透過強化人際依賴轉移患者對疼痛的感知

B.專注於辨識和改變與疼痛相關的非理性思考模式

C.改善可能導致或加劇疼痛體驗的人際溝通和關係

D.透過建立良好醫病關係，提升疼痛相關治療的遵從性

8.在布朗芬弗倫納（Bronfenbrenner）的生態系統理論之中，一個人所居住的鄰里社區位於那一個系統？

A.巨系統（macrosystem）

B.間系統（mesosystem）

C.微系統（microsystem）

D.外系統（exosystem）

9.針對厭食症的認知行為治療（CBT），下列敘述何者錯誤？

A.結合住院與認知行為治療，厭食症狀之減輕可以持續超過一年

B.住院之後繼續進行認知行為治療可以減少厭食症狀復發的風險

C.認知行為治療、心理動力治療及門診心理治療對提升身體質量指數（BMI）的效果差異很大

D.較年長以及症狀較嚴重的個案，能從認知行為治療中獲得最大助益

10.關於「夢魘症（nightmare disorder，又稱作惡夢）」之描述，下列何者錯誤？

A.在發生創傷經驗後的夢魘，可能會複製威脅性的情境

B.經常伴隨輕微自主神經活化，包括出汗、心跳加速和呼吸急促

C.從兒童期至青春期之盛行率會逐步減少

D.與較高的自殺想法和企圖有關

11.關於社會支持，有些研究提出「隱形的支持（invisible support）」是最好的，何謂「隱形的支持」？

A.所有「非實質」的社會支持，都稱為隱形的支持

B.不會引發任何生理喚起的一種社會支持方式

C.不讓受支持者感到自己無能或覺得自己拖累對方的社會支持

D.在日常生活中，來自陌生人無意間的關心，即是隱形的支持

12.實證研究發現，當氣喘個案吸入無害的安慰劑時，研究者提供個案假的回饋（譬如：告訴個案他們的呼吸道有接近阻塞的情形），許多個案接下來真的開始變得呼吸困難。此歷程由下列何種原理解釋最恰當？

A.替代學習

B.引導式想像

C.古典制約

D.操作制約

13.根據損害健康行為的重要信念「不切實際的樂觀（unrealistic optimism）」，其認為嚼檳榔者在明知有罹癌風險的情況下仍會繼續使用，最主要的理由為何？

A.嚼檳榔者相信自己可以隨時戒檳榔而不會產生任何後果

B.他們低估了檳榔的成癮性

C.他們認為自己罹患與食用檳榔有關的疾病的可能性較小

D.他們不知道戒檳榔可能帶來的健康風險

14.各類自殺風險因子中，下列那一個關鍵因素最能預測從自殺想法轉變為自殺行動？

A.與情緒疾患共病

B.衝動性

C.社會支持不足

D.無助感

15.下列何者不是進行員工諮商前需具備的相關知識？

A.壓力理論

B.職業病與職業傷害

C.人際溝通技巧

D.財務管理理論

16.對於18歲以下的族群裡使用菸草、酒精的描述，下列何者錯誤？

A.為使年輕人拒絕菸草，可以減少電影中年輕人吸菸的印象

B.要阻止想買菸的未成年者，應由家長負起責任，社區對此議題是無法改善的

C.對年輕族群來說，酒精不像其他藥物濫用，很可能使用一次就釀成威脅生命的情況（如酒駕）

D.以家庭為焦點並結合學校為基礎的介入計畫，有助於延後開始喝酒及每天會喝醉的情況

17.經諮商後，個案得到的感受，下列何者不能算是被「賦權（empowerment）」？

A.相信自己可以改變環境

B.相信自己的無助永遠都會被接納

C.相信他有力量掌握自己命運

D.相信他在這個社會有一定的控制權

18.小明罹患重度憂鬱症多年，自半年多前出院後始終無法順利就業，舉目無親再加上所剩無幾的存款造成他極大壓力。此等不利於疾病復原的情況，在個案概念化（case formulation）的4 Ps模式中被視為何種因子？

A.前置因子（predisposing factor）

B.誘發因子（precipitating factor）

C.持續因子（perpetuating factor）

D.保護因子（protecting factor）

19.關於心理障礙症的性別差異，下列敘述何者正確？

A.DSM-5採用的是性差異（sex differences）的觀點

B.心理障礙症會受到性和性別差異（sex and gender differences）的影響

C.DSM-5沒有任何關於性別的特別註明

D.個體對於疾病的感受不會受到性別影響

20.下列何者不屬於DSM-5中「智能不足」的社會領域（social domain）適應功能缺損？

A.人際溝通技巧

B.語言能力

C.金錢管理

D.經營友誼

21.研究顯示強迫症（OCD）在 fronto-striatal circuits的功能異常，下列那一個神經解剖位置不是在 fronto-striatal circuits？

A.orbitofrontal cortex

B.caudate nucleus

C.amygdala

D.anterior cingulate cortex

22.關於自戀型人格障礙症（narcissistic personality disorder）的敘述，下列何者正確？

A.若同時共病焦慮症，多數會尋求醫療協助，因此通常預後較佳

B.兒童期遭受到忽視是該類障礙症其中一項危險因子

C.自戀型人格障礙症個案傾向將成功歸因於自己的能力，無畏於他人的批評

D.藉由維持與他人的關係來建立自我感

23.下列何者最不可能是性功能障礙的危險因子？

A.重度的吸菸

B.過度接收性相關媒體訊息

C.曾遭受性虐待

D.服用血清素回收抑制劑

24.若以思覺失調症病程發展的角度來看，弱顯化精神病症候群（attenuated psychosis syndrome）最可能出現在下列那一個階段？

A.病前階段（premorbid stage）

B.前驅階段（prodromal stage）

C.發病階段（onset stage）

D.慢性化階段（chronic stage）

25.下列那一項文化因素最容易導致飲食障礙症的發生？

A.人際關係受挫

B.個人成就的壓力

C.家庭成員的高標準

D.社群媒體對纖瘦體型的推崇

26.關於解離性身分障礙症的理論觀點，下列何者符合創傷後模式（posttraumatic model）的看法？

A.童年時期嚴重的身體或性侵害事件後，大部分的個案會發展成解離性身分障礙症

B.轉換人格的出現是個體受到他人暗示，回應自身創傷經驗的一種角色扮演

C.個體於創傷後發展出轉換型人格，說明了解離症狀是用來因應創傷的關鍵因子

D.轉換人格的創傷經驗會傳遞到另一個轉換人格的身上

27.由於雙相情緒障礙症的異質性大，因此DSM-5提供數種特徵（亞型）予臨床工作者下診斷使用，其中對特徵（亞型）的敘述，下列何者錯誤？

A.「季節型」代表每年的特殊時節會發病

B.「快速循環型」代表一年至少四次躁症發作或者鬱症發作，無須考慮症狀緩解期間或症狀的轉換

C.「憂鬱病性」特徵只限於憂鬱發作當下的描述

D.「有情緒一致的精神病特徵」是指雙相情緒障礙症中的妄想或幻覺內容或主題，與當時的情緒特性是一致的

28.關於鬱症（major depressive disorder）的敘述，下列何者正確？

A.鬱症的盛行率通常高於持續性憂鬱症

B.鬱症在女性與男性身上的盛行率相當

C.鬱症的盛行率不太受到文化經濟因素影響

D.鬱症發作的平均年齡正逐漸上升

29.根據DSM-5，關於自閉症類群障礙症（autism spectrum disorder）的敘述，下列何者錯誤？

A.在多重情境中持續有社交溝通及社交互動的缺損

B.侷限、重複的行為、興趣或活動模式

C.症狀必須在早期發展階段出現

D.診斷分為自閉症（autistic disorder）與亞斯伯格症（Asperger's disorder）

30.根據DSM-5，關於恐慌症（panic disorder）診斷的敘述，下列何者錯誤？

A.反覆出現非預期性的恐慌發作（panic attack）

B.恐慌發作在幾分鐘內便達到高峰

C.發作期間必須出現診斷準則所列舉的症狀至少4項

D.若同時有預期性與非預期性的恐慌發作，則不符合恐慌症的診斷

31.根據DSM-5，關於特定場所畏懼症（agoraphobia）的敘述，下列何者錯誤？

A.主要是害怕在特定場合下自己的表現被人負面評價

B.相對於其他畏懼症，此畏懼症有最強的遺傳性

C.此畏懼症經常呈現慢性化發展

D.此畏懼症的患者若亦符合恐慌症（panic disorder）的標準，兩種診斷可並存

32.下列何種大腦結構的體積大小與創傷後壓力症之出現最有關聯？

A.杏仁核

B.前額葉

C.海馬迴

D.前扣帶迴

33.Kubany與Manke（1995）提出，創傷倖存者常會有罪惡感的產生，而這些罪惡感是建立在許多的錯誤思考上。「個人認為自己當時可以做更好的選擇（雖然實際情況未必如此），而自己卻是做了差勁的選擇」的想法屬於下列那一種錯誤思考？

A.後見之明的偏誤（hindsight bias）

B.道德扭曲（morality distortion）

C.正當性扭曲（justification distortion）

D.惡行扭曲（wrongdoing distortion）

34.關於辯證行為治療（dialectical behavior therapy）的敘述，下列何者正確？

A.「辯證」強調的是要去駁斥個案的錯誤信念

B.該治療認為個案從小的成長環境常讓其情緒在失調（dysregulation）及不認可（invalidation）兩端擺盪

C.全然接納個案代表贊同她／他的一切行為

D.心智化（mentalization）是治療中訓練個案的重要技巧

35.下列那一種類型的物質使用障礙症尚未有合適的藥物替代方案？

A.酒精

B.菸癮

C.古柯鹼

D.鴉片類

36.治療強迫症常用且具實證療效的介入「暴露和反應防止法（exposure and response prevention, ERP）」，下列何者為其主要作用機制？

A.永久消除強迫性的想法

B.漸進式地使個體對其恐懼去敏感化來減輕焦慮

C.透過建立新的且更適應性之習慣來取代強迫性儀式行為

D.教育個體辨識並迴避觸發其強迫想法的因素

37.人際心理治療（interpersonal psychotherapy, IPT）對於憂鬱症的治療，其療效具有實證研究的證據。下列何者不是此治療取向的核心？

A.個案經歷的角色轉換

B.個案經歷的失落經驗

C.個案的人際訊息注意力處理偏誤

D.個案經歷的人際衝突

38.小美因為持續性憂鬱症接受心理治療中，在治療中她提及主管和同事常稱讚她的文案很有創意，可作為範本；但是小美總認為那樣的成果只是僥倖，自己沒有能力。一位認知行為治療取向的心理師會協助小美辨識這是那一種偏誤思考？

A.全有全無

B.過度類化

C.個人化

D.取消或減少正向思考

39.依據美國國家精神衛生研究院（The National Institute of Mental Health）的資料，關於焦慮症的介入方式，下列敘述何者錯誤？

A.認知行為治療為可行的介入方式

B.壓力管理技巧可用以減緩情緒起伏

C.藥物治療是一種安全的治療方式，可以在治療初期請醫師開立慢性處方箋

D.尋求親朋好友的支持也有幫助，但無法取代醫師或其他專業醫療之介入

40.下列何者為注意力不足／過動症（attention-deficit/hyperactivity disorder）常見的非藥物介入方式？

A.人際取向的心理治療

B.行為治療

C.短期住院治療

D.飲食控制